

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	護理過程記錄原則				
	Nursing Progress Record Principle				
編號	A31000-Q08-W-004	制定者	CCU 林炳蓁	公布日期	93 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 4.5 版/10 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員能了解護理過程書寫原則並能正確書寫。

二、範圍

護理部所有相關人員（含中興分院）。

三、說明

（一）護理評估含入院護理評估及其他護理評估，須於入院 8 小時內完成，營養不良高危險群篩選則於 24 小時內完成即可。

- 1.入院護理評估以系統性評估進行，內容包括：病人之基本資料、過去病史、家族史、一般外觀、皮膚狀況、心肺系統、泌尿系統、胃腸及營養、肌肉骨骼系統、神經系統、生殖系統、心理社會靈性及疼痛評估。依年齡區分為「成人入院護理評估」、「小兒入院護理評估」與「新生兒入院護理評估」。
- 2.疼痛評估為第五生命徵象，入院時與病人之生命徵象測量時間同步評估及測量，三班依監測生命徵象時間評值病人疼痛情形，若符合疼痛問題者需書寫疼痛相關護理問題。
- 3.其他護理評估包含跌倒危險因子評估、壓力性損傷危險因子評估、營養不良高危險群篩選、心理評估、出院準備服務評估、衰弱評估...等。
- 4.跌倒危險因子評估 ≥ 4 分、壓力性損傷危險因子評估 ≤ 16 分、焦慮評估 ≥ 1 分且定義性特徵（客觀資料）符合 2 項焦慮問題者，需書寫相關護理問題。
- 5.營養不良高危險群篩選：以簡易營養篩選工具(Malnutrition universal screening tool, MUST)進行評估，總分 < 2 分為中度危險群，總分 ≥ 2 分為高度危險群或嚴

主題名稱	護理過程記錄原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q08-W-004	版本	第 4.5 版	頁碼/總頁數	2/10

重營養障礙症狀，總分 ≥ 2 分系統自動轉介營養科，營養師於 48 小時內完成訪視。

6.心理評估：以簡式健康量表（Brief Symptom Rating Scale,簡稱 BSRS-5u，又稱心情溫度計）進行心理評估，排除 12 歲以下孩童、安寧病人外，住院病人全面評估，且並自動轉介個案管理師。當(1)自殺想法 ≥ 2 分或自殺想法 ≥ 1 分且心情溫度計 ≥ 15 分，個案管理師於 72 小時內完成訪視；(2)自殺想法=1 分且心情溫度計 10~14 分或自殺想法=0 分且心情溫度計 ≥ 15 分，個案管理師於一星期內完成訪視。

7.衰弱評估： ≥ 65 歲以上病人，於入院或轉入病房 72 小時內，進行衰弱評估，若任 1 項「是」得 1 分，為衰弱前期(Pre-Frailty)，護理人員需給予衰弱衛教指導。

8.物理性約束評估：病人入院或當觀察到病人產生行為問題，（如：認知障礙、跌倒危險、行為紊亂、自傷或傷人）時，若評估可能會有約束之需求，依病人行動限制（隔離、約束）之作業標準執行並完整記錄於 HIS 住院護理系統/護理評估/物理性約束頁面。物理性約束紀錄包含：病人意識程度、約束方式、約束部位、約束地點、是否使用鎮靜劑、有無照顧者、翻身、患者狀況、約束皮膚狀況、有無鬆開約束等。

（二）經護理評估病人若呈現身體、心理、社會需求需下立護理問題。對於自我照顧困難病人，能指導或協助家屬執行身體清潔護理並下立相關護理問題或有紀錄。長期住院、身體心像改變，有出院後續照護問題等情況，須呈現心理或社會問題。

（三）護理計劃須於病人入院當班內完成。

（四）護理計劃具個別性並因病人需求與病情變化修正。

（五）護理問題符合病人生理、心理、社會之需求。

1.病人住院後 24 小時內需下至少 2 個護理問題。

2.護理問題須與病人病況吻合（疾病相關）。

主題名稱	護理過程記錄原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q08-W-004	版本	第 4.5 版	頁碼/總頁數	3/10

3.病人住院後每 7 天應重新評估。

4.當主客觀資料有改變或護理問題未改善，要重新檢視主客觀資料。

5.病人轉單位，轉入單位須重新評估護理問題及護理措施之合宜性。

6.每日白班及小夜班護理紀錄呈現護理問題的評值。

(六) 設立具體的護理目標（需填上日期）並有成效追蹤與評值。

(七) 確實執行護理計劃。

(八) 護理活動包含對病人／家屬的衛生指導並記錄於護理紀錄。

1.各項侵入性檢查，提供檢查前、後衛教資訊並紀錄。

2.一般病房：住院 24 小時內應至少有二項衛教指導項目；加護單位：住院 72 小時內應至少有二項衛教指導項目；病人住院超過 7 天、14 天與視病人情況，需有新的衛教指導項目。

3.病人由一般病房轉至加護病房或由加護病房轉回一般病房，轉床後的第 1 天、7 天及 14 天與視病人情況，需有新的衛教指導項目。

4.其中一項衛教指導項目須與疾病相關。

5.衛教指導後 72 小時內（或病人出院前）應進行評值。

(九) 護理照護過程能有醫療團隊人員聯繫溝通意見之呈現，例如：會診、各項醫療活動，需評值並作詳實完整之紀錄。

(十) 瞭解並掌握病人對治療、檢查、處置等之經過及效果、確實記載於病歷。

1.治療、檢查、處置等醫囑，在護理記錄上呈現經過、效果及病人治療後之反應（例如：輸血與藥物過敏反應）。

2.臨時給藥後用藥評值：靜脈給藥為 15 分鐘評值，其他途徑給藥皆為 30 分鐘評值，七大類藥品（退燒藥止痛藥、止痛鎮靜藥物、 α -Block 降血壓藥品、降壓藥、易造成跌倒藥物、降血糖藥品及麻醉劑等），藥物評值時間依其藥品特性以資訊系統輔助跳出提示視窗之時間進行評值，例如：Insulin (actrapid、novorapid)在給藥後 2 小時需觀察是否有低血糖症狀（頭暈、冒冷汗、無力、心

主題名稱	護理過程記錄原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q08-W-004	版本	第 4.5 版	頁碼/總頁數	4/10

跳加快、嘴唇發麻)、Propofol 給藥當下及給藥後 5 分鐘監測血壓及呼吸，評估後自動帶入護理紀錄。

3.凡特殊藥物之醫囑，應依病人個別性於治療後或給藥後，在護理記錄上呈現病人之反應及成效。

4.病人使用以下藥物：Dopamine、Levophed、Dobutamine、Gipamine、Bosmin、Lidocaine、Cordarone，護理紀錄要書寫用藥劑量。

5.已過執行時間卻未執行之藥物、檢查或檢驗之原因應在護理記錄中呈現。

(十一) 護理照護過程需紀錄同意書簽屬之完整性。

(十二) 持續性護理評估

1.病人入住加護病房，需進行「加護病房每日護理評估」，書寫原則為

(1)意識形態、生命徵象、呼吸型態需確實評估後填寫，亦可匯入最近一筆數值。

(2)氧氣用法欄位若有使用呼吸器需填寫使用種類及設定值。

(3)排泄狀況直接匯入前一天數值，若為新病人則填寫當日數值。

(4)營養狀況欄位白蛋白值匯入最近一筆數值；且需填寫點滴熱量及每日攝食熱量，包含自備食物。

(5)每日護理評估後若有身體、心理、社會需求則應下立相關護理問題。

2.一般病房病人若住院期間病情有變化或由加護病房轉病房或住院超過 7 天時需進行「一般病房護理評估」，每週至少評估一次，且由資訊系統 7Am 自動於工作清單跳出未評提示，轉床後提示以轉床後重新計算，護理同仁於提示當日 7：00~22：00 完成評估，評估後若有身體、心理、社會需求則應下立相關護理問題。

3.壓力性損傷及跌倒危險因子評估：病人一入院或由加護單位轉入 8 小時內由主護護理人員評估，每週至少重新評估一次，若病人病情改變，如：意識改變、肢體活動程度改變、發生跌倒、發生壓力性損傷須立即重新評估並依評估結果

主題名稱	護理過程記錄原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q08-W-004	版本	第 4.5 版	頁碼/總頁數	5/10

提供合宜照護。

4.營養不良高危險群篩選：病人入院 24 小時內由主護護理人員評估，住院 14 天需重新評估。

5.衰弱評估：若入院或轉入病房 72 小時內評估無衰弱風險（總分 0 分），則於出院前須進行再評估。

6.心理評估：憂鬱症、酒精濫用/依賴、HIV、非創傷性腦出血等入院診斷碼的自殺高風險病人，若未被收案，住院第 7 天需再重評一次，加護病房意識不清患者轉出時，病房需再重評。

（十三）病人轉出至其他單位時，須於護理紀錄書寫病人現況及轉出原因。

（十四）病人出院時，護理記錄必需呈現出院護理摘要，內容包括：衛教、回診時間，出院計畫及護理指導完成後電子簽名上傳。如下轉至其他機構（例如：安養機構），須提供轉院護理照護摘要，以達持續性護理。

（十五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（一）護理過程紀錄正確性稽核表。

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

主題名稱	護理過程記錄原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q08-W-004	版本	第 4.5 版	頁碼/總頁數	6/10

(略)

主題名稱	護理過程記錄原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q08-W-004	版本	第 4.5 版	頁碼/總頁數	7/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
93.01.31	1.0	新制定	93 年 01 月 31 日 護理部護理紀錄標準組委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.06.09	2.1	刪除：說明（八）出院準備服務評估護理指導及照會紀錄單。	100 年 06 月 09 日 護理部護理紀錄標準組委員會通過
102.02.07	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.03.06	3.1	新增說明（十）護理照護過程需紀錄同意書解釋之時間、地點、何人解釋、向誰解釋。	102 年 03 月 06 日 護理部護理紀錄標準組委員會通過
102.12.01	3.2	新增說明內容之各項護理過程	102 年 12 月 13 日 護理部護理紀錄標準組委員會通過
103.06.30	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.06.09	3.3	1. 第三項第(一)目之 2.新增：跌倒評估 ≥ 4 分、壓瘡評估 ≤ 12 分、焦慮評估 ≥ 1 分且定義性特徵(客觀資料)符合 2 項焦慮問題者，需書寫相關護理診斷。 2. 新增第三項第(三)目疼痛評估內容。 3. 第三項第(六)目之 1 新增：病人住院後 24 小時內需下至少 2 個護理問題。	104 年 06 月 09 日 護理部護理紀錄標準組委員會通過
105.03.08	3.4	1. 增修第三項第(一)目之部份內容：入院系統性護理評估於 8 小時內完成，其他護理評估於病人入院後當班內完成。 2. 第三項第(二)目內容修正。 3. 第三項第(九)目之 2 修正~病人住院超過 7 天及 14 天，需有新的衛教指導項目。 4. 第三項第(九)目之 3 新增：病人由一般病房轉至加護病房或由加護病房轉回一般病房，轉床後的第 1 天、7 天及 14 天內需有新的衛教指導項目。	104 年 06 月 09 日 護理部護理紀錄標準組委員會通過

主題名稱	護理過程記錄原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q08-W-004	版本	第 4.5 版	頁碼/總頁數	8/10

修正日期	版本	修正說明	備註
		5. 第三項第(十二)目修正為~護理照護過程需紀錄同意書簽屬之完整性。 6. 新增第三項第(十三)目加護病房每日護理評估書寫原則內容。	
105.09.06	3.5	1. 第三項第(一)目之 1.增加心理評估。 2. 第三項第(二)目新增心理評估內容。 3. 新增第三項第(十二)目一般病房護理評估書寫時機內容。	105 年 09 月 06 日 護理部護理紀錄標準組委員會通過
106.04.19	3.6	1. 第三項第(一)目刪除：跌倒評估、壓瘡評估、營養評估、出院準備；改為~跌倒危險因子評估、壓瘡危險因子評估、營養不良高危險群篩選、出院準備服務評估。 2. 第三項第(十)目之 2 增修：臨時給藥後有用藥成效追蹤評值：除了 Insulin(actrapid、novorapid)、Propofol 兩項高警訊藥品依其藥品特性以資訊系統輔助跳出提示視窗之時間進行監測評值外，靜脈給藥為 15 分鐘監測評值，其他途徑給藥皆為 30 分鐘監測評值。Insulin(actrapid、novorapid)在給藥後 2 小時需觀察是否有低血糖症狀（頭暈、冒冷汗、無力、心跳加快、嘴唇發麻）、Propofol 給藥前及給藥後 5 分鐘監測血壓及呼吸。 3. 新增第三項第(十二)目之 4 內容。	106 年 04 月 19 日 護理部護理長會議決議通過
107.03.13	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.03.26	3.7	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第一目之 3.4 第十二目之 3 壓瘡更改為壓力性損傷。 3. 第三項第十三目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 03 月 26 日 護理紀錄組會議通過；108 年 04 月 10 日 護理長會議通過；108 年 04 月 23 日 督導會議通過公布。
108.09.23	3.8	第三項第一目之 4 修訂壓力性損傷危險因子評估 ≤16 分	108 年 09 月 03 日 護理紀錄組會議通過；108 年 09 月 11 日 護理長會議通過；108 年 09 月 23 日 督導會議通過公

主題名稱	護理過程記錄原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q08-W-004	版本	第 4.5 版	頁碼/總頁數	9/10

修正日期	版本	修正說明	備註
			布。
109.03.10	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.04.06	3.9	第三項第一目之 6 說明內容修訂。	110 年 03 月 16 日護理紀錄組會議通過;110 年 03 月 17 日護理長會議通過;110 年 04 月 06 日督導會議通過公布
111.04.12	4.0	1. 第三項第五目新增 2.護理問題須與病人病況吻合（疾病相關）。 2. 第三項第八目新增 4.其中一項為教指導項目須與疾病相關。	111 年 03 月 07 日護理紀錄組會議通過;111 年 03 月 09 日護理長會議通過;111 年 04 月 12 日督導會議通過公布
112.03.14	4.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.07.04	4.1	第三項第十目之 2 臨時給藥後用藥評值說明內容修訂。	112 年 06 月 13 日護理紀錄組會議通過;112 年 06 月 14 日護理長會議通過;112 年 07 月 04 日督導會議通過公布。
113.04.16	4.2	1. 主題名稱修訂。 2. 第三項第一目說明內容修訂。 3. 第三項第一目新增 7.衰弱評估。 4. 第三項第五目內容修訂。 5. 第三項第十目之 2.及 4. 說明內容修訂。 6. 新增第三項第十二目之 5.衰弱評估內容。 7. 新增第三項第十二目之 6.心理評估內容。 8. 新增第三項第十三目病人轉出至其他單位時，須於護理紀錄書寫病人現況及轉出原因。	113 年 03 月 21 日護理紀錄組會議通過;113 年 04 月 10 日護理長會議通過;113 年 04 月 16 日督導會議通過公布。

主題名稱	護理過程記錄原則	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q08-W-004	版本	第 4.5 版	頁碼/總頁數	10/10

修正日期	版本	修正說明	備註
		9. 新增第三項第十四目病人出院時，護理記錄必需呈現出院護理摘要內容包括說明。	
114.04.08	4.3	1. 第三項第五目之 3 及 6 說明內容修訂。 2. 第三項第八目之 2：刪除:超過 7 天及 14 天 新增:後每 7 天應重新評估 3. 第三項第八目之 3： 刪除:轉床後的第 1 天、7 天及 14 天內需有新的衛教指導項目。 新增: 接病人當班主護即完成新的衛教指導項目，並每 7 天應重新評估。	114 年 03 月 11 日 護理紀錄組會議通過;114 年 03 月 12 日 護理長會議通過;114 年 04 月 08 日 督導會議通過公布。
114.07.08	4.4	1. 第三項第二目新增：對於自我照顧困難病人，能指導或協助家屬執行身體清潔護理並下立相關護理問題或有紀錄。 2. 第三項第八目之 2：刪除：後每 7 天應重新評估 新增：超過 7 天及 14 天視病人情況 3. 第三項第八目之 3： 刪除: 接病人當班主護即完成新的衛教指導項目，並每 7 天應重新評估。 新增：轉床後的第 1 天、7 天及 14 天與視病人情況。 4. 第三項第十四目：轉出（院）護理照護摘要修改為：轉院護理照護摘要 5. 第四項：護理紀錄書寫稽核總表。 改為：護理過程紀錄正確性稽核表。	114 年 06 月 10 日 護理紀錄組會議通過;114 年 06 月 11 日 護理長會議通過;114 年 07 月 08 日 督導會議通過公布。
115.04.07	4.5	第三項第一目新增第 8 點：物理性約束評估	115 年 02 月 10 日 護理紀錄組會議通過;115 年 03 月 18 日 護理長會議通過;115 年 04 月 07 日 督導會議通過公布。